

TEMA 7.22 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos de Personalidad: Clúster C y Casos Clínicos

PERFIL EUNACOM 1.09.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los trastornos de la personalidad representan patrones persistentes e inflexibles de experiencia interna y comportamiento que se apartan de las expectativas de la cultura del individuo. En esta sesión, profundizaremos en el **Trastorno de la Personalidad Dependiente**, el **Trastorno de la Personalidad Obsesivo-Compulsivo (TPOC)** y sus diagnósticos diferenciales clave para el EUNACOM.

Trastorno de la Personalidad Dependiente

Este trastorno se caracteriza por una necesidad excesiva de ser cuidado, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego, junto con un intenso temor a la separación.

Características Principales

- **Relaciones Verticales:** El paciente suele establecer vínculos donde se sitúa en una posición de subordinación. Puede permitir voluntariamente que otros se aprovechen de él para mantener la relación y evitar el abandono. - **Búsqueda Activa de Sustitutos:** Ante la ruptura de una relación estrecha, el individuo busca urgentemente otra relación que le proporcione cuidado y apoyo. Esta urgencia a menudo nubla su juicio, llevándolo a elegir parejas inapropiadas o "tóxicas". - **Dificultad para la Autonomía:** Existe una incapacidad percibida para valerse por sí mismo, lo que genera una dependencia funcional y emocional constante.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diferencia clave con el Trastorno de Personalidad Límitrofe (TLP): Aunque ambos temen el abandono, la reacción es distinta: 1. **TLP:** Lucha desesperada, rabia, agresividad e inestabilidad para recuperar *esa relación específica*. 2. **Dependiente:** Sumisión ("haré lo que quieras") y búsqueda rápida de una *relación diferente* para llenar el vacío.

Trastorno de la Personalidad Obsesivo-Compulsivo (TPOC)

Es fundamental no confundir el **TPOC** (un trastorno de personalidad) con el **Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)**, que pertenece al espectro de los trastornos de ansiedad.

Perfil Clínico del TPOC

- **Perfeccionismo Patológico:** El detalle extremo impide finalizar las tareas. "Lo perfecto es enemigo de lo bueno". Por ejemplo, un estudiante que no termina de leer el temario del EUNACOM por intentar memorizar cada palabra del primer capítulo. - **Dedicación Excesiva al Trabajo:** Priorizan la productividad sobre el ocio y las relaciones interpersonales, descuidando a su familia y su propio bienestar físico. - **Rigidez y Obstinación:** Son personas inflexibles en temas de moral, ética y valores. A diferencia del **Trastorno de Personalidad Antisocial**, que ignora las normas, el TPOC es un "hiper-seguidor" de las reglas, juzgando duramente a quien las flexibiliza. - **Avaricia y Acumulación:** Les cuesta gastar dinero (incluso si tienen los medios) y tienden a guardar objetos inútiles por la ansiedad que les genera desecharlos ("por si acaso sirve después").

NOTA CLÍNICA

Egosintonía vs. Egodistonia: - **TPOC (Personalidad):** Es **Egosintónico**. El paciente cree que su forma de ser (ser extremadamente limpio o detallista) es la correcta y que los demás son los que están mal. - **TOC (Ansiedad):** Es **Egodistónico**. El paciente sufre por sus obsesiones y compulsiones, reconoce que son absurdas o excesivas y desearía no tenerlas.

TABLA 7.22.1: CARACTERÍSTICA VS TRASTORNO DE PERSONALIDAD OBSESIVO-COMPULSIVO (TPOC)

CARACTERÍSTICA	TRASTORNO DE PERSONALIDAD OBSESIVO-COMPULSIVO (TPOC)	TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC)
Naturaleza	Estilo de vida, forma de ser persistente.	Presencia de obsesiones y compulsiones específicas.
Percepción	Egosintónico (está de acuerdo con su forma de ser).	Egodistónico (le genera malestar y conflicto).
Síntomas	Rigidez, perfeccionismo, orden excesivo.	Ideas repetitivas (obsesiones) y rituales para calmar la angustia (compulsiones).

Diagnóstico Diferencial mediante Casos Clínicos

Para el EUNACOM, es vital distinguir trastornos de personalidad de otras patologías psiquiátricas.

1. Trastorno Evitativo vs. Trastorno Esquizoide

- **Caso 1:** Hombre solitario, tímido, solo tiene amigos familiares y baja autoestima. - **Diagnóstico: Trastorno de la Personalidad Evitativo.** El paciente *quiere* tener vínculos pero tiene miedo al rechazo. - **Caso 2:** Hombre solitario, vive tranquilo y no le interesa tener amigos. - **Diagnóstico: Trastorno de la Personalidad Esquizoide.** Hay un desinterés intrínseco por las relaciones sociales.

2. Trastorno Evitativo vs. Fobia Social

- **Caso 3:** Persona vergonzosa a la que le aterra exponer en público, pero tiene pareja y amigos. - **Diagnóstico: Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social).** El problema es el escrutinio público, no una forma de ser que afecte todas sus relaciones interpersonales.

3. Trastorno Paranoide vs. Trastorno Delirante

- **Caso 6:** Hombre asegura que su mujer lo engaña y usa una marca en la muralla (sin sentido) como prueba irrefutable. - **Diagnóstico: Trastorno Delirante Crónico (Celotipia).** Hay una pérdida del juicio de realidad (psicosis). - **Caso 7:** Hombre muy celoso, se enoja fácilmente porque se siente atacado por los demás y busca significados ocultos. - **Diagnóstico: Trastorno de la Personalidad Paranoide.** Es una suspicacia generalizada sin llegar al delirio psicótico estructurado.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Para diagnosticar un **Trastorno de Personalidad**, los rasgos deben ser persistentes, ubicuos (ocurren en todos los ámbitos) y, sobre todo, deben causar un **deterioro funcional** o problemas significativos en las relaciones interpersonales. Tener "rasgos" (ser ordenado o ser tímido) es normal; el trastorno es el extremo patológico.

Resumen de Perlas EUNACOM

- **Narcisista:** Clasifica a los demás como inferiores ("retrasados", "envidiosos") y se aprovecha de ellos (ej. dejar los peores turnos a los compañeros).
- **Dependiente:** "Un clavo saca a otro clavo". Cambia de pareja inmediatamente para no estar solo.

- **TPOC en el estudio:** Si estás atrasado con el EUNACOM por querer saberlo todo perfecto, recuerda que la prioridad es cubrir toda la materia. El perfeccionismo extremo aquí es un rasgo de TPOC que juega en contra.
- **Tratamiento:** Tanto el trastorno evitativo como el dependiente suelen responder favorablemente a una psicoterapia bien dirigida.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el examen, si el paciente presenta **compulsiones marcadas** (lavarse las manos 50 veces) y **angustia** por ello, marca **TOC**. Si el paciente es **exigente con los demás** para que limpien y está orgulloso de su rigor, marca **TPOC**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 30 años refiere que quiere tener amigos y pareja pero que siempre que alguien le habla siente que la van a rechazar y se retira. Tiene solo 1 amiga con quien es muy cercana. Su autoestima es muy baja. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos de Personalidad: Clúster C y Casos Clínicos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El TPOC es egosintónico: el orden y los rituales son correctos para él; el TOC es egodistónico: el paciente sufre con sus compulsiones.
- El trastorno evitativo: baja autoestima + quiere relaciones pero las evita por miedo al rechazo; diferente del esquizoide (no las quiere) y la fobia social (solo en situaciones de escrutinio público).
- El trastorno dependiente: inseguridad extrema, no toma decisiones solo, busca nueva relación inmediatamente al terminar la anterior (no lucha por la misma como el límite).
- Para diagnosticar trastorno de personalidad los rasgos deben causar disfunción interpersonal o afectar la vida de la persona.
- El trastorno de personalidad paranoide es desconfiado y celoso pero NO psicótico; el trastorno delirante celopático SÍ pierde el juicio de realidad.
- El narcisista que dice que su jefe lo envidia y que todos son mediocres es el cuadro egosintónico más clásico del narcisismo.
- La diferencia entre TPE y fobia social: el TPE evita relaciones en general; la fobia social solo evita situaciones de exposición pública con vida social normal de lo contrario.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS DE PERSONALIDAD: CLÚSTER C Y CASOS CLÍNICOS)

PREGUNTA 1

Mujer de 30 años refiere que quiere tener amigos y pareja pero que siempre que alguien le habla siente que la van a rechazar y se retira. Tiene solo 1 amiga con quien es muy cercana. Su autoestima es muy baja. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A) Trastorno de personalidad esquizoide
- B) Trastorno de personalidad evitativo
- C) Fobia social (trastorno de ansiedad social)
- D) Trastorno de personalidad dependiente
- E) Depresión mayor con aislamiento social

PREGUNTA 2

Hombre de 40 años es muy ordenado y metódico. Le molesta que sus hijos dejen cosas fuera de lugar y se enoja cuando los demás no respetan las normas. Dice que "el orden es lo correcto y los demás están equivocados si no lo hacen así". No tiene obsesiones intrusivas ni compulsiones que le generen malestar. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A) TOC; ISRS + psicoterapia
- B) Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo; psicoterapia
- C) Trastorno bipolar; estabilizador del ánimo
- D) Esquizofrenia residual; antipsicótico atípico
- E) Trastorno de personalidad narcisista; psicoterapia

PREGUNTA 3

Mujer de 28 años acude al médico porque se separó de su pareja. Refiere que "ya tiene otra persona" con quien está saliendo hace 1 semana. No puede tomar decisiones sola, siempre necesita que le digan qué hacer. Le pregunta al médico si debe volver con el exnovio o quedarse con el nuevo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Trastorno de personalidad límite
- B) Trastorno de personalidad dependiente
- C) Trastorno adaptativo por separación; psicoterapia
- D) Trastorno de personalidad evitativo
- E) Fobia social; ISRS

RESUMEN: TRASTORNOS DE PERSONALIDAD: CLÚSTER C Y CASOS CLÍNICOS

El clúster C agrupa los trastornos de personalidad con rasgos ansiosos sin ser trastornos ansiosos propiamente. El trastorno de personalidad evitativo se caracteriza por baja autoestima marcada con deseo de relaciones sociales que se evitan por miedo al rechazo; tiene amigos muy escasos o ninguno. Diferente de la fobia social (que mantiene vida social normal fuera de situaciones de exposición pública) y del esquizoide (que no quiere relaciones). Tiene buen pronóstico con psicoterapia. El trastorno de personalidad dependiente tiene inseguridad extrema con dificultad para tomar decisiones independientemente; necesita apoyo constante, no expresa desacuerdo, se somete para mantener la relación y busca inmediatamente una nueva relación al terminar la anterior. Se diferencia del límite en que el dependiente busca nuevas relaciones de manera pasiva, mientras que el límite lucha agresivamente por recuperar la misma relación. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo (TPOC) es diferente del TOC: el TPOC es egosintónico (el orden y los rituales son correctos y los demás están equivocados), mientras que el TOC es egodistónico (la compulsión es vista como un problema propio). El TPOC se caracteriza por ser muy ordenado, metódico, detallista hasta lo contraproducente, dedicado excesivamente al trabajo y los estudios en detrimento de la vida personal, obstinado, con rigidez moral e inflexible. Tendencia al ahorro excesivo y a la acumulación. Es frecuente que el TPOC venga de base en personas con TOC. Un principio importante: para diagnosticar un trastorno de personalidad se requiere que los rasgos causen disfunción en las relaciones interpersonales o en la vida de la persona. Tener rasgos de personalidad no es patológico. El diagnóstico diferencial entre trastornos de personalidad similares se hace por el motivo central de la disfunción relacional.